

إسم المريض رابعياً : ورده رواش حواش اسماعيل

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : اوسيم

رقم البطاقة : 27607172101783 رقم التليفون : 01123699704

العمر(تاريخ الميلاد) : 17-07-1976 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----)

المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعة مقطعية مخ مع صبغة [10851] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : -----

GR1-E
جورستان
روستای پلانی
لندی حسن
موسین رمضان
صحة البیابان المرفقة
للجنة و مدین

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

نَفَقَات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ورده رواش حواش اسماعيل National ID: 27607172101783	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of the brain.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

ورده
رواش حواش اسماعيل
قرية البراجيل
مركز اوسيم - الجيزة

١٩٧٦/٠٦



٢٧٦.٠٧١٧٢١.١٧٨٣

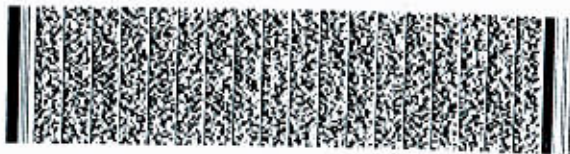
LE3016962



٢٠٢٥/٠٦ ٢٧٦.٧١٧٢١.١٧٨٣

ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
مبروك محمد يوسف صوابي
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٦/١٣



Patient Name: Warda Rawash Hawash Ismail	Date : 14/12/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 2631/2022	Pat. ID: 15850

**POST-CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST ,
ABDOMEN AND PELVIS : -**

**Compared to last study dated 30/6/2025 current study
revealed:**

Findings:

- Left MRM with clear operative bed.
- Clear right breast and both axilla.
- Clear both lung fields.
- Lingular multiple fibrotic bands are seen.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- linear atelectatic band at left apical lung segment .
- Average size liver showing homogenous attenuation .
No C.T. evidence of hepatic focal lesions.
- * Average size spleen , no focal lesions.
- *No dilated intra or extra-hepatic bile ducts .
- *Urinary bladder shows no masses or stones.
- *Normal C.T. appearance of the pancreas , adrenal glands, both kidneys ,bowel loops & other pelvic organs.
- *No retroperitoneal lymphadenopathy .
- *No ascites .

Name: ورده رواش حواش اسماعيل		
MR. : 1290		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 50-year-old individual who is premenopausal. The clinical history notes a left breast cancer treated with modified radical mastectomy on 28/9/2022, staged as T3N2M0. Adjuvant therapy included four cycles of AC, 12 cycles of TaroL, postoperative radiotherapy, and ongoing tamoxifen planned until 6/2025. Bone metastases have been documented. Histopathology from the biopsy demonstrated invasive ductal carcinoma (IDC). Hormone-receptor testing showed estrogen receptor 8/8 and progesterone receptor 8/8, while HER2 was not amplified; the Ki-67 proliferation index is 30. The patient is being managed for metastatic breast cancer to bone with a CDK4/6 inhibitor plus Faslodex and is clinically progressive disease with a performance status of 3. Brain MRI revealed right frontal calvarial bone metastases, a large sellar mass, and a heterogeneous appearance of the clivus measuring 3.4 × 3.3 × 3.1 cm. CT of the chest, abdomen, and pelvis showed a left modified radical mastectomy tumor-bed lesion with heterogeneous fat-low density and diffuse osseous metastases. The referring team recommended Affinitor, Aromazine, Zoladex, and Zometa. The multidisciplinary team concurred and the outcome and plan are to proceed with Affinitor, Aromazine, Zoladex, and Zometa.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 23-09-2026
		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name: Warda Rawash Hawash Ismail	Date : 14/12/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 2631/2022	Pat. ID: 15850

- Progressive course as regards the multiple mixed lytic/sclerotic lesions now involving most of axial and appendicular skeleton.
- Forward slippage of L4 over L5 due to pars fracture .
- Compression fracture of D10.

Opinion:

- **Progressive course as regards the osseous metastasis with stationary course of the rest of the study.**

Dr. Mai Shaaban MD

?

Name : Warda Rawash Hawash Ismail

Date : 31-12-2025 11:39

Branch : Dokki

Medical No. : 286030

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Ins.Company : تعافد مستشفيات

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- A 49-year-old lady, with history of left breast cancer, referred for metastatic work up.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- Widespread active foci seen at skull, bilateral ribs, multi-levels of the spine, proximal humeri, pelvic bones and both femora.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- Widespread metastatic osseous lesions as described.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

1 / 20 07.06/0

Clinical Data

BX:

JD c III

R

ER: 8/8

PR: 1-4/2
2/2

HER 2:
2-

Ki67:

Not Amplified

ps:2

No VI Seal

Sonomammography:

premy p Mer. Brett
(New development)

Mets Workup:

High pressure left front

LR HAM on 28/9/2022 $\frac{1}{2}$, N_2 , H_2

Лес. 4 AC. (125 га)

TNM

Recommendations:

~~POMF ST. TAM 5/2023 (all)~~

↳ 6/2025 in Bone Met

Skull, Ribs, Acl., Sup pubic b.
effluence B. S.S.

Left hand, Rt. S. 7

Q. 2. a) / 2

CTD 4

0/6 Hildel
Wachstum

MDT OUTCOME & PLAN

7/29

7. Approval CDK 16 / Feb 19
CDK 16 / Feb 19
CDK 16 / Feb 19

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

Psychiatric

Patient Name : الأستاذة / زنده رواش خراش اسماعيل
Patient No. : 27607172101783
Path No. : 2531/22
Sex : Female
Age : 46 Y
Referring Doc :
Request No. : 13008857
Request Date : 29/03/2022
Verification Date : 13/09/2022
Financial Category : فئة ثالثة
Department : Out Patient
Registered by : manwa mohamed you

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast cancer.

Nature of the specimen: Left MRM specimen.

Gross Examination: Three specimens were received; submitted as: 1- Left MRM specimen measured 23x16x4cm with skin covering measured 21x15 cm.

• Tumor extent

• Number: Cut section revealed grayish white firm mass.

• Size: measured 7x5 cm.

• Skin involvement: Nipple showed grayish white firm areas.

• Distance from margins: 1cm from deep margin.

• Lymph nodes number and size: Axillary dissection revealed 13 lymph nodes up to 1cm.

2- Right WLE and 2 right axillary lymph nodes: Wired fibrofatty tissue piece measured 10x5x4cm with skin covering measured 4x1cm. Cut section revealed grayish white firm mass measured 3x2x1cm, 0.1cm from deep margin. 2 lymph nodes was found measured 1*0.5cm.

3- Right Major duct excision: Wired fibrofatty tissue piece measured 5x4x1cm.

1- Microscopic examination of left MRM specimen :

• Histological type: Invasive duct carcinoma.

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G!! (3+2+1).

• Angioinvasion: Positive.

• Ductal carcinoma in situ: No.

• Tumor extent

• Skin involvement: Nipple showed paget 's disease.

• Lymph node involvement: Positive in (6/11).

• Resection Margins: Free deep margin.

Verified by :

DR. Menna Nabil

Printing Date : 17/09/2022 14:02:09

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa

Patient Name : الأمانة / وريده زواش جواش اسماعيل	Request No. : 13005923
Patient No. : 27607172101783	Request Date : 26/05/2022
Path No. : 1420/2022	Verification Date : 15/06/2022
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 45 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

2- Right breast mass:

- Compatible with intraductal papilloma.

3- Right axillary LN:

- Fibrofatty tissue with areas of hemorrhage.

Diagnosis:

Bilateral breast masses & Right axillary lymphadenopathy, Tru-cut biopsy:

1- Left breast mass:

- Invasive duct carcinoma grade II
- Focal ductal carcinoma insitu
- ER : Positive (8/8)
- PR : Positive (8/8)
- HER2: Equivocal (score2+)
- SiSH: Not amplified
- Ki 67: 30 % nuclear reaction

2- Right breast mass:

- Compatible with intraductal papilloma, for excision.

3- Right axillary LN:

- Fibrofatty tissue with areas of hemorrhage

Prof.Dr.Gamal Abdelatty
Dr.Menna Nabil

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 15/06/2022 12:58:08

Page 2 of 3

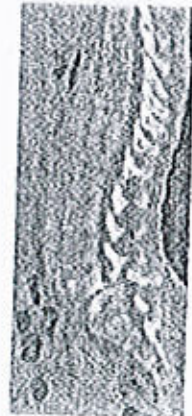
Printing By : dr.esraa magdy

Patient Name: Warda Rawash Hawash Ismail	Date : 30/06/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 2631/2022	Pat. ID: 15850

**POST-CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST ,
ABDOMEN AND PELVIS : .**

Findings:

- Left mastectomy.
- Clear both lung fields
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- linear atelectatic band at left apical lung segment .
- Average size liver showing homogenous attenuation . No C.T. evidence of hepatic focal lesions.
- * Average size spleen , no focal lesions.
- *Average size gall bladder , three gall stones.
- *No dilated intra or extra-hepatic bile ducts .
- *Urinary bladder shows no masses or stones.
- *Normal C.T. appearance of the pancreas , adrenal glands, both kidneys ,bowel loops & other pelvic organs.
- *No retroperitoneal lymphadenopathy .
- *No ascites .
- Multiple lytic lesions of left acetabular bone with compression fracture of D10 vertebra.
- Forward slippage of L4 over L5 due to pars fracture .
- Uterine calcified lesion likely myoma.



Opinion:

Known case of breast cancer shows:

- Left acetabular bony bubbly lytic lesions likely metastatic for correlation with bone scan.
- D10 compression fracture likely metastatic .
- L4/L5 grade II lytic spondylolisthesis.
- No pulmonary or hepatic deposits.

DR/Reham Khedr...MD

Signature Of Mohamed El...